

Obstrucción laríngea

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Libro de ORL Diamante

Etiología más frecuente

- RN
 - Atresia de coanas
- Primeras horas de vida
 - Parálisis del N. Recurrente bilateral
- Primeras semanas de vida
 - Laringomalacia
- Primeros meses de vida
 - Estenosis subglótica congénita
 - Angioma subglótica

Laringomalacia

> frecuente en lactantes (hasta los 2 años)

Benigna

Autolimitada

Producido por prolapso anormal de las estructuras supraglóticas durante la **inspiración**

En múltiples ocasiones asociado a traquiomalacia (colapso anteroposterior de la tráquea)

Etiología

Retraso en la maduración de los tejidos y estructuras que componen la laringe y tráquea, tiende a disminuir con la edad.

Puede agravarse por RGE y/o CVAS

Características

- Empeora con el llanto y excitación
- Es inspiratorio, de baja frecuencia
- Sin cianosis

Diagnóstico

- Clínica + fibroscopía flexible
- Rx de perfil laríngeo (de partes blandas)

Tratamiento

- Leve: conducta expectante
- Moderado y grave: Qx si afecta el crecimiento

Estenosis subglótica congénita

En general en RNPT

Afectación por debajo de cuerdas vocales

Presenta laringitis a repetición y apneas

Afectación bifásica (inspiratoria y espiratoria)

Diagnóstico

- Clínico: por rápida descompensación respiratoria
- Rx en hiperinsuflación
- Endoscopia rígida

Tratamiento

- Conducta expectante
- “Split” laríngeo
- Laringofisura, laringoplastia

Angioma subglótica

Más frecuente en mujeres

Asociado a hemangiomas cutáneos en otros sitios

Desaparece antes de los 12 años

Síntomas entre los 2-6 meses

- Bifásico: mayormente inspiratorio
- Cambios variables del llanto
- Disfonía
- Tos perruna
- Laringitis persistente
- Empeora con CVAS

Diagnóstico

Clínica

Rx perfil laríngeo } Estenosis asimétrica subglótica

Rx tórax }

Endoscopia rígida

Tratamiento

En general es de resolución espontánea

Corticoides

Traqueotomía

Parálisis del nervio recurrente

- Bilateral: congénito
- Unilateral: posterior a cirugía, traumatismo, intubación o SNG

Características

1. Bilateral

Bifásico, agudo, fijo

Empeora con el llanto, excitación y alimentación

Desde el nacimiento

En general mejora a los 6-12 meses

Si es severa puede haber cianosis, gran esfuerzo respiratorio y alteraciones en el crecimiento, en estos casos se realiza traqueotomía.

2. Unilateral

Afectación izquierda más frecuente

Episodios de aspiración

Tos y llanto débil y solapado

Tratamiento: expectante, suelen compensar el defecto con l otra cuerda vocal. Si esto no sucede se realiza tratamiento quirúrgico.